

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH (MBI)

Eje IV: Funcionamiento Ocupacional y Estrés • Modelo Tridimensional de Desgaste Profesional

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario de Burnout de Maslach (MBI; Forma Human Services Survey - MBI-HSS).
Nombre Original	Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach & Jackson, 1981, 1986, 1996).
Autoras Originales	Christina Maslach, Ph.D. y Susan E. Jackson, Ph.D. (Univ. of California, Berkeley / Rutgers).
Adaptación Hispana	Nicolás Seisdedos (TEA Ediciones, 1997); Gil-Monte y Peiró (1997, 1999); España y LatAm.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Funcionamiento Ocupacional y Estrés. Síndrome de desgaste profesional o burnout.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 22 reactivos balanceados con escala de frecuencia de 7 niveles (0 a 6).
Población y Rango	Profesionales en activo de servicios humanos, sanitarios, docentes, policías y trabajadores sociales.
Tiempo de Administración	10 a 15 minutos en autoadministración individual o cribados laborales colectivos.
Régimen de Licencia	Comercial / Propietario. Propiedad de Mind Garden, Inc. / Distribuido en España por TEA Ediciones.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO TRIDIMENSIONAL DE BURNOUT

El **Inventario de Burnout de Maslach (MBI)** es el estándar de oro psicométrico para la evaluación del **síndrome de desgaste profesional** (reconocido en la CIE-11 como fenómeno ocupacional QD85). Christina Maslach y Susan Jackson conceptualizaron el burnout no como una fatiga física pasajera, sino como una respuesta psicológica prolongada a estresores interpersonales crónicos en el trabajo:

1. **Agotamiento Emocional (EE):** El núcleo fisiológico y vivencial del síndrome; vaciamiento progresivo de los recursos afectivos e incapacidad de entregarse psicológicamente a otros.
2. **Despersonalización / Cinismo (DP):** Desarrollo de respuestas frías, cínicas, insensibles y deshumanizadas hacia los usuarios, pacientes o clientes como mecanismo defensivo disfuncional.
3. **Baja Realización Personal en el Trabajo (PA):** Sentimiento crónico de ineficacia profesional, pérdida de competencia laboral y fracaso en el proyecto vocacional personal.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (22 REACTIVOS MBI-HSS)

Dimensión Psicométrica	Nº Ítems	Contenido y Reactivos Clave Evaluados (MBI-HSS)
1. Agotamiento Emocional (EE)	9 ítems	Sentirse consumido por el trabajo, cansado al levantarse, frustrado y al límite de sus fuerzas.
2. Despersonalización (DP)	5 ítems	Trato impersonal a usuarios como si fueran objetos, endurecimiento emocional e indiferencia.
3. Realización Personal (PA)	8 ítems	Capacidad de crear un clima agradable, comprender problemas ajenos y sensación de eficacia (sentido inverso).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN LABORAL

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La adaptación española de TEA Ediciones (Seisdedos, 1997; Gil-Monte, 2002; $N > 3.500$ profesionales) confirma su solidez métrica:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Agotamiento (EE)	Alfa $\alpha = 0.88 - 0.90$	Excelente fiabilidad interna; constituye la dimensión más robusta del síndrome.
Consistencia Despersonaliz. (DP)	Alfa $\alpha = 0.76 - 0.82$	Buena coherencia métrica para una escala breve de 5 reactivos.
Consistencia Realización (PA)	Alfa $\alpha = 0.78 - 0.84$	Adecuada fiabilidad en la medición de autoeficacia laboral subjetiva.
Estabilidad Test-Retest	Test-retest $r = 0.82$	Estabilidad demostrada en reevaluaciones a 4 semanas en personal sanitario estable.
Validez Estructural	CFA Tridimensional	Confirmación del modelo de 3 factores independientes (CFI > 0.92 , RMSEA < 0.05).
Validez Predictiva (Bajas)	Odds Ratio = 3.6	Puntuaciones altas en EE y DP predicen absentismo laboral y bajas por incapacidad temporal.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO POR DIMENSIONES SEPARADAS

- **Opciones de Frecuencia Temporal:** Escala Likert de 7 puntos: Nunca (0), Pocas veces al año (1), Una vez al mes o menos (2), Pocas veces al mes (3), Una vez a la semana (4), Pocas veces a la semana (5), Todos los días (6).
- **Cálculo por Subescalas:** Se calcula la suma directa de los reactivos correspondientes a cada dimensión:
 - **Agotamiento Emocional (EE):** Suma de 9 ítems (rango **0 a 54 puntos**).
 - **Despersonalización (DP):** Suma de 5 ítems (rango **0 a 30 puntos**).
 - **Realización Personal (PA):** Suma de 8 ítems (rango **0 a 48 puntos**).
- **Prohibición de Suma Total Unificada:** Las autoras originales y las guías metodológicas prohíben explícitamente sumar las 3 subescalas en un único índice global compuesto, dado que representan dimensiones ortogonales cualitativamente distintas.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN DEL BURNOUT

Nivel Clínico	Agot. (EE)	Desp. (DP)	Realiz. (PA)	Significación Ocupacional y Diagnóstica (TEA)
Bajo	0 a 18 pts	0 a 5 pts	≥ 40 pts	Sin desgaste profesional; motivación y eficacia laboral preservadas.
Medio / Típico	19 a 26 pts	6 a 9 pts	34 a 39 pts	Estrés laboral moderado; signos iniciales de fatiga psicológica.
Alto / Crítico	≥ 27 pts	≥ 10 pts	≤ 33 pts	Síndrome de Burnout estructurado; severo agotamiento y cinismo.

CRITERIO CLÍNICO DE BURNOUT COMPLETO (LA TRÍADA PATOLÓGICA):

El diagnóstico de **Síndrome de Burnout Severo** requiere la presencia simultánea de la tríada clínica: **Agotamiento Emocional Alto (≥ 27)**, **Despersonalización Alta (≥ 10)** y **Baja Realización Personal (≤ 33)**.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE INTERVENCIÓN EN MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD MENTAL

PROTOCOLO SECUENCIAL DE ACTUACIÓN ANTE DESGASTE PROFESIONAL:

- **Paso 1 (Cribado Preventivo Anual):** Evaluar anualmente en servicios hospitalarios de urgencias, cuidados intensivos, oncología y centros de educación especial.
- **Paso 2 (Detección de Agotamiento Aislado [EE $\geq$ 27, DP normal]):** Intervenir tempranamente con redistribución de turnos laborales, descansos obligatorios y entrenamiento en desconexión digital fuera de guardia.
- **Paso 3 (Intervención ante Despersonalización Elevada [DP $\geq$ 10]):** Implementar talleres de supervisión de casos clínicos complejos con grupos Balint, recuperando el sentido empático del trabajo con el usuario.
- **Paso 4 (Abordaje en Tríada Completa):** Tramitar baja laboral temporal por incapacidad temporal por contingencia común/profesional, combinada con psicoterapia cognitivo-conductual centrada en establecimiento de límites y reestructuración de esquemas de autoexigencia implacable.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN MÉDICO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

Identificación: Varón de 41 años, médico adjunto del servicio de urgencias hospitalarias con 12 años de ejercicio. Consulta por insomnio de conciliación, palpitaciones pre-guardia, distanciamiento clínico hacia los pacientes ("me da igual lo que les pase, solo quiero que despejen camas") y severo conflicto con la dirección médica.

Evaluación Psicométrica Inicial MBI-HSS:

- **Agotamiento Emocional (EE) = 44 / 54 puntos (Nivel Alto Extremo; Percentil 96 normativo).**
- **Despersonalización (DP) = 18 / 30 puntos (Nivel Alto Extremo; Percentil 95 normativo).**
- **Realización Personal (PA) = 22 / 48 puntos (Nivel Muy Bajo / Crítico; Percentil 8 normativo).**

Diagnóstico e Intervención: Se confirmó Síndrome de Burnout Severo estructurado. Salud Laboral prescribió baja médica temporal durante 8 semanas. Se aplicó Terapia Cognitivo-Conductual integrando Terapia de Esquemas para desactivar el perfeccionismo implacable y entrenamiento en mindfulness. Se coordinó con la gerencia hospitalaria la exención de guardias nocturnas consecutivas a su reincorporación.

Reevaluación a los 5 Meses: EE descendió a **19 / 54 pts** (rango medio), DP se redujo a **6 / 30 pts** y la Realización Personal aumentó a **39 / 48 pts**. El facultativo retomó su puesto con actitud empática y límites laborales firmes.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

BURNOUT VS. DEPRESIÓN MAYOR:

El burnout se limita al ámbito laboral (mejora en vacaciones). Si la anhedonia y desesperanza persisten durante los fines de semana y fuera del trabajo, diagnosticar Episodio Depresivo Mayor.

RIESGO DE ERROR MÉDICO / NEGLIGENCIA:

Puntuaciones en Despersonalización > 15 en sanitarios se asocian a un aumento estadísticamente significativo del riesgo de cometer errores de prescripción o diagnósticos por desatención.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behavior*, 2(2), 99-113.
2. Seisdedos, N. (1997). *MBI: Inventario de Burnout de Maslach. Manual*. TEA Ediciones.
3. Gil-Monte, P. R., & Peiró, J. M. (1999). Perspectivas teóricas y modelos interpretativos para el estudio del síndrome de quemarse por el trabajo. *Anales de Psicología*, 15(2), 261-268.
4. Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. *Annual Review of Psychology*, 52, 397-422.